UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Rhumatologie
Dépistage et prévention ostéoporose
Sans patient
Sans geste clinique

Nom du rédacteur : Léo Jauvert **Date de rédaction : 16/12/2023**

Relecture intra-ou transdisciplinaire :

Situation de départ N°306 - Dépistage et prévention ostéoporose

Domaine de compétence n°1: Synthèse des résultats d'examens paracliniques

Domaine de compétence n°2: Stratégie pertinente de prise en charge

Attendus d'apprentissage de la situation abordée:

1- Interpréter les résultats d'une ostéodensitométrie

2- Identifier les situations justifiant l'introduction d'un traitement pharmacologique anti-ostéoporotique

Patient simulé nécessaire à la station : NON

Matériel nécessaire à la station

- Mannequin NON
- Brancard NON
- 1 table, 1 chaise, 1 ostéodensitométrie + 1 bilan biologique + 1 EPP à imprimer

Instructions à l'étudiant

Vous êtes médecin généraliste.

Vous recevez ce jour Mme Marchandise, 69 ans, à qui vous aviez prescrit une ostéodensitométrie et un bilan biologique il y a 2 semaines suite à une fracture de Gérard-Marchand secondaire à une chute de sa hauteur. En dehors d'un tabagisme actif à 30 PA, elle n'a pas d'antécédent, notamment pas de notion d'autre fracture. Elle revient ce jour avec les résultats de ces examens.

Vous avez **8 minutes** pour :

1. Interpréter les résultats de l'ostéodensitométrie et du bilan biologique
2. Énoncer à voix haute la prise en charge globale préconisée, notamment médicamenteuse, et ses modalités.

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Nom : [redacted]
ID du patient : [redacted]
DDN : [redacted]

Sexe : Féminin
Age de Ménopause : 50

Taille : 161.0 cm
Poids : 57.0 kg
Age: 69

Médecin traitant : [redacted]

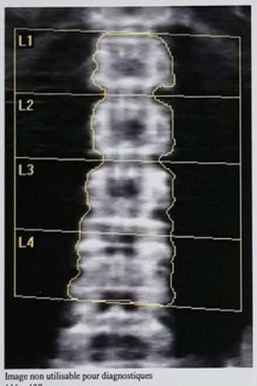


Image non utilisable pour diagnostiques
116 x 137
DAP: 3.7 cGy*cm²

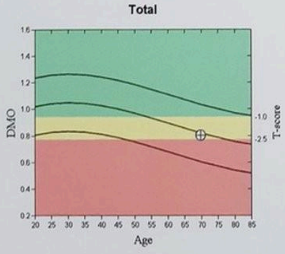
Information d'examen :

Scan Date: 27 Septembre 2018 ID: A09271806
Type d'examen : fe Lumbar Spine
Analyse: 27 Septembre 2018 14:28 Version 13.3.0.1
Colonne lombaire
Opérateur :
Modèle : Explorer (S/N 90178)
Commentaire :

Résumé des résultats DXA :

Région	Surface (cm²)	CMO (g)	DMO (g/cm²)	T - score	Z - score
L1	11.09	7.13	0.643	-2.6	-0.7
L2	12.25	9.04	0.738	-2.6	-0.6
L3	15.36	13.58	0.884	-1.8	0.4
L4	16.49	14.57	0.884	-2.1	0.1
Total	**55.19**	**44.33**	**0.803**	**-2.2**	**-0.1**

Total DMO CV 1.0%



Commentaire :

Nom : [redacted]
ID du patient : [redacted]
DDN : [redacted]

Sexe : Féminin
Age de Ménopause : 50

Taille : 161.0 cm
Poids : 57.0 kg
Age: 69

Médecin traitant : [redacted]

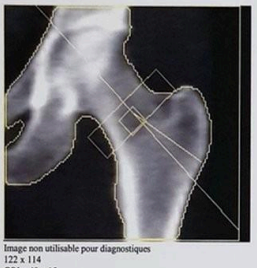


Image non utilisable pour diagnostiques
122 x 114
COL : 49 x 15
DAP: 2.5 cGy*cm²

Information d'examen :

Scan Date: 27 Septembre 2018 ID: A09271807
Type d'examen : fe Left Hip
Analyse: 27 Septembre 2018 14:27 Version 13.3.0.1
Hanche gauche
Opérateur :
Modèle : Explorer (S/N 90178)
Commentaire :

Résumé des résultats DXA :

Région	Surface (cm²)	CMO (g)	DMO (g/cm²)	T - score	Z - score
Col	4.91	2.69	0.547	-2.7	-0.9
Total	**30.18**	**20.67**	**0.685**	**-2.1**	**-0.6**

Total DMO CV 1.0%

FRAX® WHO Fracture Risk Assessment Tool

Risque de fracture à 10 ans[1]

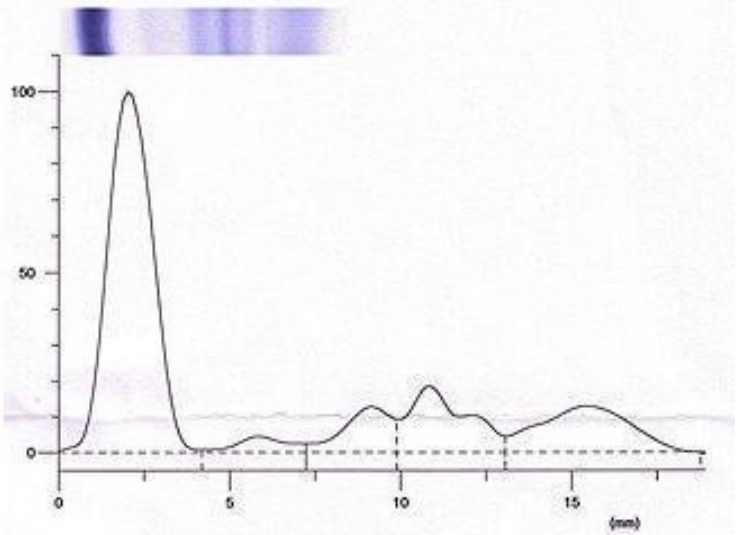
Fracture ostéoporotique importante 8.9%
Fracture de Hanche 3.4%

Facteurs de risque signalé :
France, T-score(WHO)=-2.6, BMI=22.0

[1] FRAX® Version 3.05. Fracture probability calculated for an untreated patient. Fracture probability may be lower if the patient has received treatment.

Commentaire :

N° de Dossier



Technique sur gel d'agarose

Index	Fraction	% Relatif	Conc. (g/l)	Normales (g/l)
1	Albumine	59.50%	39.86	35.00 ... 50.00
2	Alpha 1	2.98%	2.00	1.00 ... 4.00
3	Alpha 2	7.94%	5.32	5.00 ... 11.00
4	Beta	13.99%	9.37	6.00 ... 13.00
5	Gamma	15.60%	10.45	7.00 ... 16.00
Total			67.00	*60.00....80.00*

Rapport A/G 1.47

Hémoglobine	13,5 g/dL
Leucocytes	7 G/L
Formule leucocytaire	Normale
Plaquettes	218 G/L
CRP	3 mg/L
Calcémie	2,3 mmol/L
Phosphate	0,9 mmol/L (**N: 0,81 - 1,45**)
Créatininémie	67 µmol/L
CKD-EPI	72 mL/min/1,73m2
25OH - vitamine D	16 ng/mL
ASAT	20 U/L
ALAT	19 U/L
GGT	8 U/L **(N: 5–36)**
PAL	50 U/L **(N: 35 - 104)**

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Fiche de correction pour l'évaluateur (sans le barème)

	Cocher si fait
Tâche 1	
Relève le T score < -2,5 au rachis lombaire et au col	
Décrit la normalité du bilan biologique (hors déficit en vitamine D)	
Note le déficit en vitamine D	
Note l'absence d'insuffisance rénale	
Conclut au diagnostic d'ostéoporose **FRACTURAIRE**	
Tâche 2	
Prescrit une **supplémentation en Vitamine D** +/- supplémentation calcique (*si apports insuffisants*)	
Préconise un sevrage tabagique	
Préconise la mise en place ou maintien d'une activité physique en charge	
Met en place un dépistage et prise en charge des facteurs de risque de chute	
Prescrit des biphosphonates oraux en 1ère intention	
Décrit les modalités de prise: le matin, à jeun, avec un grand verre d'eau peu minéralisée (Cocher si 2 sur 3)	
Déconseille de se coucher dans les 30 minutes suivant la prise	
Demande une consultation dentaire **AVANT** biphosphonates	
Prévoit un suivi clinique au minimum annuel	
Prévoit une réévaluation à 2-3 ans par une nouvelle ostéodensitométrie	
COMPÉTENCES GÉNÉRIQUES	
Aptitude à faire la synthèse des données	
Aptitude à proposer une prise en charge	

Fiche de correction avec le barème : non communiqué à l'évaluateur

	Cocher si fait
Tâche 1	
Relève le T score < -2,5 au rachis lombaire et au col	2
Décrit la normalité du bilan biologique (hors déficit en vitamine D)	2
Note le déficit en vitamine D	2
Note l'absence d'insuffisance rénale	1
Conclut au diagnostic d'ostéoporose **FRACTURAIRE**	2
Tâche 2	
Prescrit une **supplémentation en Vitamine D** +/- supplémentation calcique (*si apports insuffisants*)	2
Préconise un sevrage tabagique	2
Préconise la mise en place ou maintien d'une activité physique en charge	1
Met en place un dépistage et prise en charge des facteurs de risque de chute	1
Prescrit des biphosphonates oraux en 1ère intention	3
Décrit les modalités de prise: le matin, à jeun, avec un grand verre d'eau peu minéralisée (Cocher si 2 énoncés sur 3)	3
Déconseille de se coucher dans les 30 minutes suivant la prise	2
Demande une consultation dentaire **AVANT** biphosphonates	2
Prévoit un suivi clinique au minimum annuel	1
Prévoit une réévaluation à 2-3 ans par une nouvelle ostéodensitométrie	1
COMPÉTENCES GÉNÉRIQUES	
Aptitude à faire la synthèse des données	1 à 5
Aptitude à proposer une prise en charge	
NOTE TOTALE	**Total / 37**